proregen

GUIA PARA PACIENTES

PRP: o plasma rico em plaquetas

O que é, como é feito e o que a ciência mostra no joelho, no quadril, nos tendões, na coluna e nas feridas. Com honestidade, sem promessas.

Conteúdo educativo. Não substitui a consulta médica.
Baseado em estudos científicos publicados até outubro de 2026.

EDIÇÃO 2026

ANTES DE COMEÇAR

Uma conversa franca sobre o PRP

Talvez você já tenha ouvido falar em tratamento "com o próprio sangue". Este guia explica, em linguagem simples, o que é o PRP, onde ele ajuda, onde ainda está em estudo e onde não mostrou benefício.

O que é o PRP

PRP quer dizer **plasma rico em plaquetas**. As plaquetas são pequenas partes do sangue que ajudam a estancar sangramentos. Elas também liberam substâncias que sinalizam ao corpo que um tecido precisa de reparo.

No PRP, separamos e concentramos essas plaquetas a partir de uma pequena amostra do **seu próprio sangue**. Depois, o concentrado é aplicado no local da lesão.

O PRP é um procedimento médico auxiliar e complementar: não substitui o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia indicada.

COMO LER ESTE GUIA

As bolinhas ●●●○○ mostram a força das evidências científicas em cada área: quanto mais bolinhas, mais segura é a informação.

O PRP **não é cura** e não serve para todos. Ele pode fazer parte de um plano que inclui exercícios, fisioterapia e mudanças de hábito.

01	Como o PRP é feito e o que esperar	3
02	Mapa da evidência, área por área	4
03	Joelho, menisco e quadril	5
04	Tendões, ligamentos e ossos	6
05	Coluna e feridas	7
06	Segurança e quem pode ser candidato	8
07	Perguntas frequentes	9
08	Referências e contato	10

Do seu sangue ao local da lesão

O procedimento é feito em ambiente médico apropriado e costuma durar menos de uma hora. Na coluna, é feito em ambiente hospitalar ou de hospital-dia.

1

Avaliação

Consulta, exame físico e revisão dos exames de imagem. É aqui que se decide se o PRP faz sentido para o seu caso.

2

Coleta do sangue

Uma amostra pequena é coletada da veia do braço, como num exame de sangue comum.

3

Preparo

O sangue vai para uma centrífuga, que separa as plaquetas. Existem tipos diferentes de PRP, com mais ou menos glóbulos brancos. O médico escolhe o tipo conforme a lesão.

4

Aplicação

Após a limpeza da pele, o PRP é injetado no local, muitas vezes guiado por ultrassom para mais precisão. Em alguns casos são feitas 2 ou 3 aplicações, com semanas de intervalo.

5

Recuperação

É comum sentir dor ou inchaço no local por 2 a 3 dias. Em geral, anti-inflamatórios devem ser evitados nesse período, pois podem atrapalhar a ação das plaquetas. O médico orienta repouso relativo e a volta gradual às atividades.

> O QUE ESPERAR
>
> O PRP não age como um analgésico. Quando funciona, a melhora costuma ser gradual, ao longo de semanas, e o resultado varia de pessoa para pessoa. Nenhum resultado pode ser garantido.

Onde o PRP ajuda, onde ainda não sabemos

Resumo do que os estudos mostram hoje. É um ponto de partida para conversar com o seu médico, não uma indicação.

> **O PRP é um procedimento médico auxiliar e complementar. Ele não substitui o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia quando indicada.**

ÁREA	FORÇA	O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM
Joelho com artrose	●●●●○	Boa evidência
Cotovelo de tenista	●●●●○	Boa evidência
Feridas crônicas	●●●●○	Boa evidência
Tendão patelar	●●●○○	Evidência moderada
Fascite plantar	●●●○○	Evidência moderada
Reparo do menisco (junto com a cirurgia)	●●○○○	Resultados mistos
Glúteo médio (dor na lateral do quadril)	●●○○○	Resultados conflitantes
Quadril com artrose	●●○○○	Efeito modesto
Disco da coluna lombar	●●○○○	Em estudo
Tendão de Aquiles	●○○○○	Sem benefício consistente
Manguito rotador e LCA	●○○○○	Sem benefício consistente
Cicatrização do osso	●○○○○	Em estudo
Articulações da coluna lombar	●○○○○	Em estudo
Coluna cervical	●○○○○	Em estudo, dados iniciais

Os estudos usam tipos diferentes de PRP, números de aplicações e protocolos distintos. Por isso, os resultados nem sempre podem ser comparados entre si.

Articulações que sustentam o seu peso

Joelho com artrose

●●●●○

BOA EVIDÊNCIA

É a área mais estudada. Em artrose leve a moderada, vários estudos mostram melhora da dor e da função, com resultados comparáveis ou superiores aos do ácido hialurônico e da infiltração com corticoide em alguns estudos. Costuma ser opção quando exercícios e remédios não bastaram, geralmente em 2 a 3 aplicações. Não regenera a cartilagem perdida.

Reparo do menisco (junto com a cirurgia)

●●○○○

RESULTADOS MISTOS

Aqui o PRP é aplicado durante a cirurgia que sutura o menisco, como complemento. Algumas revisões de estudos encontraram menos falhas do reparo com PRP, mas outras não mostraram melhora clara na dor e na função. A cirurgia e a reabilitação continuam sendo o tratamento principal.

Glúteo médio (dor na lateral do quadril)

●●○○○

RESULTADOS CONFLITANTES

Estudos mostraram melhora maior com PRP do que com corticoide no longo prazo, mas um estudo de 2025 não encontrou diferença entre o PRP e uma injeção de placebo. Os exercícios para o quadril seguem sendo a base.

Quadril com artrose

●●○○○

EFEITO MODESTO

Alívio dos sintomas por até cerca de 6 meses, parecido com o do ácido hialurônico. Um estudo de 2024 não achou diferença contra soro fisiológico. Não é recomendado de rotina.

Onde funciona e onde não mostrou benefício

Cotovelo de tenista

●●●●○

BOA EVIDÊNCIA

Na epicondilite lateral crônica, há estudos de alta qualidade com melhora da dor e da função no médio prazo, melhor que o corticoide.

Tendão patelar

●●●○○

EVIDÊNCIA MODERADA

Na tendinopatia crônica do joelho, comum em atletas de salto, há melhora funcional em estudos controlados.

Fascite plantar

●●●○○

EVIDÊNCIA MODERADA

Na dor crônica na sola do pé, alguns estudos mostram resultado melhor que o corticoide.

Tendão de Aquiles

●○○○○

SEM BENEFÍCIO CONSISTENTE

Os ensaios clínicos não mostraram benefício de forma consistente. Não é recomendado de rotina.

Manguito rotador e LCA

●○○○○

SEM BENEFÍCIO CONSISTENTE

Usado junto com a cirurgia do ombro ou do ligamento do joelho, o PRP não mostrou melhora clara na cicatrização ou no retorno ao esporte.

Cicatrização do osso

●○○○○

EM ESTUDO

Estudos em laboratório e pequenas séries sugerem potencial para ajudar o osso a cicatrizar. Faltam estudos maiores em pessoas.

Áreas
em estudo e em expansão

Disco da coluna lombar

EM ESTUDO

Na dor que vem do disco lombar, um ensaio clínico e revisões mostram melhora da dor em parte dos pacientes, mas os estudos ainda são poucos e pequenos. Na coluna, o procedimento é feito em ambiente hospitalar ou de hospital-dia, guiado por imagem.

Articulações da coluna lombar

EM ESTUDO

Também há estudos nas pequenas articulações que ligam uma vértebra à outra, atrás do disco. Os dados ainda são iniciais.

Coluna cervical

EM ESTUDO, DADOS INICIAIS

No pescoço, existem até agora apenas séries de casos. É cedo para saber o real benefício.

Feridas crônicas

BOA EVIDÊNCIA

Uma revisão de 2022, com 29 ensaios clínicos, mostrou chance cerca de 5 vezes maior de a ferida fechar por completo com PRP. A evidência é melhor para úlcera venosa da perna e moderada para pé diabético; para úlcera de pressão e feridas cirúrgicas, ainda é limitada. Feridas que não cicatrizam precisam também de investigação da causa.

É seguro?
E é para mim?

O PRP é considerado um procedimento de baixo risco, por usar o sangue do próprio paciente.

Efeitos mais comuns

Dor, inchaço ou rigidez no local por alguns dias. Mancha roxa no braço da coleta.

Raros

Pode ocorrer infecção no local da aplicação, o que é raro quando o procedimento segue técnica estéril.

Procure o médico se houver

- Febre, vermelhidão que se espalha ou calor intenso no local.
- Dor que piora muito depois do terceiro dia.

Pode ser uma opção para quem

Tem diagnóstico confirmado numa área com indicação, já tentou o tratamento básico (exercícios, fisioterapia, controle do peso) e entende que o resultado não é garantido.

Em geral não é indicado

Casos de infecção ativa no local, câncer ativo, doenças do sangue, alterações da coagulação ou plaquetas baixas, uso de alguns anticoagulantes, gravidez, e artrose muito avançada, em que outras opções podem ser melhores.

> **DECISÃO COMPARTILHADA**
>
> A melhor escolha é tomada junto com o seu médico, depois de uma avaliação individual.

Dúvidas que ouvimos no consultório

P Dói?

A coleta é como um exame de sangue. Na aplicação, pode haver desconforto e pressão. Nos dias seguintes, a dor local pode aumentar um pouco antes de melhorar.

P Quantas aplicações são necessárias?

Depende da área e da lesão. Em tendões, muitas vezes uma aplicação. No joelho, os estudos costumam usar 2 a 3.

P Quanto tempo dura o efeito?

Varia de pessoa para pessoa. No joelho, alguns estudos observaram benefício por 6 a 12 meses. Esse é um dado de pesquisa, não é garantia para o seu caso.

P Posso trabalhar no dia seguinte?

Na maioria dos casos, sim, com cuidado e sem esforço intenso no local nos primeiros dias.

P O PRP evita cirurgia?

O PRP não substitui a cirurgia quando ela é indicada. Essa decisão é tomada na avaliação.

P PRP é o mesmo que células-tronco?

Não. O PRP usa plaquetas do sangue. Células-tronco e outros ortobiológicos são tratamentos diferentes.

QUER CONVERSAR SOBRE O SEU CASO?

Agende uma avaliação com o Dr. André Kruel, presencial em Bento Gonçalves (RS) ou por consulta online. WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

De onde vêm estas informações

1. Le ADK et al. Current clinical recommendations for use of platelet-rich plasma. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018;11(4):624-634.
2. Sheean AJ, Anz AW, Bradley JP. Platelet-rich plasma: fundamentals and clinical applications. Arthroscopy. 2021;37(9):2732-2734.
3. Litsos S, Diamantopoulos AP, Molund M. Platelet-rich plasma in the management of musculoskeletal disorders: a narrative review. Front Med. 2026;13:1920226. doi:10.3389/fmed.2026.1920226.
4. Rothrauff BB et al. Platelet-rich plasma in the treatment of musculoskeletal disease in 2025 and beyond. Am J Sports Med. 2026;54(8):2058-2074. doi:10.1177/03635465251395284.
5. Sheth U et al. Efficacy of autologous platelet-rich plasma use for orthopaedic indications: a meta-analysis. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(4):298-307.
6. Everts PAM et al. Platelet rich plasma in orthopedic surgical medicine. Platelets. 2021;32(2):163-174.
7. Fitzpatrick J et al. Leucocyte-rich PRP treatment of gluteus medius and minimus tendinopathy: a double-blind RCT. Am J Sports Med. 2019.
8. Atchia I et al. Efficacy of PRP versus placebo for greater trochanteric pain syndrome. J Bone Joint Surg Am. 2025;107(5):444-451. doi:10.2106/JBJS.24.00763.
9. Topaloglu M et al. PRP versus placebo in hip osteoarthritis. Turk J Phys Med Rehabil. 2024;70(2):212-220. doi:10.5606/tftrd.2024.13855.
10. Zhang D et al. Intra-articular PRP versus hyaluronic acid in hip osteoarthritis: meta-analysis. Pain Res Manag. 2026;2026:e6521682. doi:10.1155/prm/6521682.
11. Tuakli-Wosornu YA et al. Lumbar intradiskal platelet-rich plasma injections: a prospective, double-blind, randomized controlled study. PM R. 2016;8(1):1-10.
12. Baltzer AW et al. PRP for lumbar facet joint syndrome: CT-guided facet injections. Orthop Rev (Pavia). 2025;17:141416. doi:10.52965/001c.141416.
13. Migliorini F et al. PRP augmentation does not result in more favourable outcomes in arthroscopic meniscal repair: a meta-analysis. J Orthop Traumatol. 2022;23(1):8.
14. Dave U et al. Platelet rich plasma augmentation for meniscus repair reduces failure but not complication rates or outcomes: a systematic review. J Orthop. 2026;73:62-71.
15. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.464, de 2 de julho de 2026. DOU 15/07/2026, Seção 1, p. 70.
16. Meznerics FA et al. Platelet-rich plasma in chronic wound management: systematic review and meta-analysis of RCTs. J Clin Med. 2022;11(24):7532.

Responsável técnico

Dr. André Kruel · Médico ortopedista

CRM-RS 23627 · RQE 14323

Contato

Proregen · Bento Gonçalves (RS) e consulta online

WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

Material educativo. Não substitui a consulta médica. Não contém preços, imagens de "antes e depois" ou depoimentos, conforme as regras de publicidade médica do CFM. Edição outubro de 2026.

proregen